



TECNOLOGÍA
MÉDICA
CAYETANO

CONTINUACIÓN · SEMANA 3

Rehabilitación basada en la comunidad

*De los principios a la práctica situada en
Terapia de Lenguaje*

Terapia de Lenguaje en
Atención Comunitaria



3

semana

Participantes (10)



🔍 Buscar un participante



MILAGROS Ro... (Anfitrión, yo)  



Arantza Gamarra



Claudia De la Cruz



Cristina Fernández García



Daniela Yupanqui



Kimberli Cardozo



LHIA JUÁREZ SAMAMÉ



MAYRA LUCERO AYALA RIVERA



Samantha Hernández



ximena abanto





Antes de continuar...

RECORDANDO LA CLASE 2 · REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD



Qué es:

La RBC es una estrategia de la OMS y la OPS para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su inclusión social.



Sus 5 principios:

Inclusión social, participación comunitaria, empoderamiento familiar, intersectorialidad y descentralización.



Rol del terapeuta:

Evaluador y facilitador, capacitador, gestor comunitario y agente de cambio dentro de un programa de RBC.





Antes de continuar...

RECORDANDO LA CLASE 2 · REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD



Hoy profundizamos: ¿qué aspectos prácticos garantizan que la Terapia de Lenguaje en RBC sea efectiva y culturalmente pertinente?



Logro de aprendizaje de la semana



Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

- Aplicar los principios de la RBC a la práctica cotidiana de la Terapia de Lenguaje en contextos culturalmente diversos.
- Reconocer los aspectos clave —culturales, comunitarios, interdisciplinarios y éticos— que garantizan una intervención efectiva y pertinente.
- Diseñar estrategias de intervención comunitaria adaptadas a la realidad social, lingüística y geográfica del Perú.





Contenido

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTOS A CONSIDERAR



La Terapia de Lenguaje en el contexto de la RBC requiere una comprensión profunda de nueve aspectos clave para que la intervención sea efectiva y culturalmente sensible.



1

**Diversidad cultural
y lingüística**



2

**Contexto
comunitario**



3

**Enfoque preventivo
y educativo**



4

**Colaboración
interdisciplinaria**



5

**Adaptación de
estrategias terapéuticas**



6

**Acceso
y equidad**



7

**Evaluación y
monitoreo continuo**



8

**Sensibilidad y respeto
por la comunidad**



9

**Capacitación
continua**



Lectura recomendada

ARTÍCULO DE REFERENCIA PARA ESTA SESIÓN



Título: *"Community-Based Rehabilitation: A Strategy to Promote Health and Well-Being in the Community"*

Autores: Valeria Amado, Marta Rodríguez y José Pérez

Publicación: Journal of Community Health and Development, 2023, Vol. 10, No. 2, pp. 123-139

Resumen: Examina cómo la rehabilitación del lenguaje puede integrarse en un enfoque basado en la comunidad para mejorar los resultados en salud y bienestar. Analiza modelos de intervención que utilizan recursos comunitarios, casos de estudio en diversas comunidades y recomendaciones para adaptar las estrategias a las necesidades culturales y sociales locales.

"Rehabilitación basada en la comunidad: una estrategia para promover la salud y el bienestar en la comunidad"





Diversidad Cultural y Lingüística

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 1 DE 9



Perú posee más de 48 lenguas originarias —quechua, aimara, awajún, asháninka, shipibo-konibo, entre otras— además de comunidades andinas, amazónicas, urbanas y afroperuanas con distintas prácticas comunicativas. El terapeuta de lenguaje debe conocer esta realidad para intervenir con pertinencia.

Evaluación pertinente

Diferenciar un trastorno del lenguaje real de una diferencia lingüística esperada en hablantes bilingües o de lenguas originarias.

Materiales adaptados

Usar referentes culturales locales (alimentos, animales, costumbres) en lugar de materiales genéricos o traducidos literalmente.

Alianzas locales

Trabajar con intérpretes o promotores bilingües de la comunidad cuando el terapeuta no domina la lengua local.



Idea clave: una diferencia lingüística no es un trastorno — la evaluación debe hacerse en la lengua materna del paciente siempre que sea posible.



Contexto Comunitario

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 2 DE 9



La rehabilitación basada en la comunidad implica trabajar estrechamente con la comunidad local para identificar sus necesidades y recursos, conociendo sus estructuras organizativas, instituciones y dinámicas antes de diseñar cualquier intervención.

Actores clave

Promotores de salud, docentes, líderes comunales y autoridades locales que sostienen la red de apoyo.

Recursos del territorio

Postas de salud, colegios, espacios comunales y organizaciones de base disponibles para articular la atención.

Diagnóstico situado

Identificar rutinas, horarios de trabajo agrícola o comercial y festividades que condicionan la asistencia a terapia.



Idea clave: ninguna intervención funciona si se diseña de espaldas al territorio — el mapeo comunitario es el primer paso, no un trámite opcional.



Enfoque Preventivo y Educativo

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 3 DE 9



La Terapia de Lenguaje en un contexto comunitario prioriza la prevención y la educación por encima del modelo puramente asistencial, promoviendo la salud del lenguaje desde una etapa temprana.

Estimulación temprana

Programas dirigidos a cuidadores para fortalecer el lenguaje desde el nacimiento y la primera infancia.

Sensibilización

Talleres sobre señales de alerta del desarrollo comunicativo para agentes comunitarios, docentes y familias.

Materiales educativos

Cartillas y afiches accesibles, adaptados al nivel educativo y cultural de cada audiencia.



Idea clave: detectar a tiempo cuesta menos —en recursos y en desarrollo perdido— que intervenir cuando la dificultad ya está instalada.



Colaboración Interdisciplinaria

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 4 DE 9



En la RBC, el terapeuta de lenguaje colabora con otros profesionales de la salud, educadores, trabajadores sociales y líderes comunitarios. Ningún resultado sostenible se logra en solitario.

Equipo ampliado

Médicos, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y líderes comunitarios participan según cada caso.

Comunicación fluida

Reuniones de coordinación periódicas, con objetivos y roles compartidos entre todo el equipo.

Redes intersectoriales

Articulación sostenida con salud, educación y protección social (MINSA, MINEDU, MIDIS).

✓ **Idea clave: el terapeuta de lenguaje es una pieza del equipo, no una isla — los mejores resultados se sostienen en red.**



Adaptación de Estrategias Terapéuticas

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 5 DE 9



Las estrategias y técnicas terapéuticas deben adaptarse a las necesidades específicas de la comunidad y a las características individuales de los pacientes, sin perder rigor clínico.

Recursos locales

Objetos cotidianos y juegos tradicionales cuando no hay materiales comerciales disponibles.

Flexibilidad horaria

Sesiones breves y horarios que respeten los tiempos de trabajo agrícola, pesquero o comercial de las familias.

SAAC pertinentes

Sistemas alternativos de comunicación adaptados a símbolos y referentes reconocibles localmente.



Idea clave: la técnica correcta es la que la familia puede sostener en casa, con lo que tiene a su alcance.



Acceso y Equidad

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 6 DE 9



Los terapeutas deben garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso equitativo a los servicios, superando barreras económicas, geográficas y culturales (retomando la accesibilidad vista en la Clase 1).

Barrera económica

Costos de traslado y tiempo laboral perdido → subsidios, horarios flexibles y atención itinerante.

Barrera geográfica

Distancia en zonas altoandinas y amazónicas → brigadas itinerantes y teleorientación.

Barrera cultural

Desconfianza o estigma hacia la discapacidad → sensibilización comunitaria previa.

✓ **Idea clave: el acceso equitativo exige atacar las tres barreras a la vez — resolver solo una no basta para llegar a todos.**



Evaluación y Monitoreo Continuo

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 7 DE 9



Es importante evaluar de manera continua la efectividad de las intervenciones y hacer ajustes según sea necesario, recolectando datos que confirmen si los programas logran sus objetivos.

Indicadores pertinentes

Medidas simples y culturalmente apropiadas, no solo instrumentos estandarizados urbanos.

Registro participativo

Involucrar a la familia y la comunidad en el seguimiento de los avances del paciente.

Ajuste continuo

Revisar y modificar el plan de intervención según los datos y resultados recogidos.



Idea clave: lo que no se mide no se puede mejorar — y lo que se mide debe tener sentido para la comunidad, no solo para el terapeuta.



Sensibilidad y Respeto por la Comunidad

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 8 DE 9



La implementación de programas de terapia de lenguaje debe realizarse con un enfoque respetuoso hacia las creencias y prácticas locales. La confianza es la base de toda intervención comunitaria.

Escuchar primero

Validar el conocimiento local sobre crianza, salud y comunicación antes de intervenir.

Involucrar líderes

Incorporar a autoridades y sabios locales en el diseño de las actividades comunitarias.

Sin imposiciones

Evitar presentar una única visión "correcta" de la comunicación o la crianza.



Idea clave: la confianza se gana escuchando primero — sin ella, ninguna estrategia terapéutica, por buena que sea, llega a sostenerse.



Capacitación Continua

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · ASPECTO 9 DE 9



Dado que las necesidades y contextos comunitarios cambian con el tiempo, el terapeuta de lenguaje debe participar en capacitación continua para mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas.

Formación continua

Cursos, diplomados y congresos sobre RBC, diversidad cultural y nuevas metodologías.

Supervisión entre pares

Espacios de intercambio con colegas que trabajan en contextos comunitarios similares.

Aprender de la comunidad

La retroalimentación local como fuente permanente de aprendizaje y mejora.



Idea clave: el contexto comunitario cambia — el terapeuta que deja de aprender, deja de ser pertinente.



De los aspectos a la práctica

SÍNTESIS · UN FLUJO PARA LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA



1

Conocer el contexto

Diversidad cultural y lingüística +
contexto comunitario del territorio.

2

Planificar con pertinencia

Enfoque preventivo, adaptación de
estrategias y acceso equitativo.

3

Intervenir en equipo

Colaboración interdisciplinaria,
sensibilidad y respeto por la
comunidad.

4

Evaluar y mejorar

Evaluación y monitoreo continuo, y
capacitación permanente del
equipo.

“

**Una Terapia de Lenguaje verdaderamente
comunitaria no impone soluciones: las construye
junto a la comunidad.**

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD · TERAPIA DE LENGUAJE EN ATENCIÓN COMUNITARIA



Ideas clave de la sesión

REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD



La pertinencia cultural y lingüística no es opcional: define si una evaluación o intervención es válida en el contexto peruano.



Conocer el territorio —actores, recursos y dinámicas sociales— es el primer paso antes de intervenir.



La colaboración interdisciplinaria y la articulación intersectorial sostienen los resultados en el tiempo.



La equidad en el acceso exige superar barreras económicas, geográficas y culturales de forma simultánea.



La confianza de la comunidad se construye escuchando primero, no imponiendo soluciones externas.



La capacitación continua del terapeuta es tan importante como la intervención misma, porque los contextos comunitarios cambian.



Referencias

LECTURAS Y FUENTES DE ESTA SESIÓN



Amado, V., Rodríguez, M. y Pérez, J. (2023). Community-Based Rehabilitation: A Strategy to Promote Health and Well-Being in the Community. *Journal of Community Health and Development*, 10(2), 123-139.



OMS, OIT, UNESCO e IDDC (2010). *Rehabilitación Basada en la Comunidad: Guías para la RBC*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.



Organización de las Naciones Unidas (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Nueva York: ONU.



Perú. Ley N.º 29973, *Ley General de la Persona con Discapacidad* (2012).



A la práctica PADLET



1

QUECHUA

10 palabras funcionales

2

AYMARA

10 palabras funcionales

3

JAQARU

10 palabras funcionales

4

ARAWAK

10 palabras funcionales

🔍 Buscar un participante



MILAGR... (Anfitrión, yo)

Silenciar



Ahnyela Paucar



Alessandra Padilla Chunga



Andrea Velasque



Arantza Gamarra



Claudia De la Cruz



Cristina Fernández García



Daniela Yupanqui



Karelli Cáceres



Kimberli Cardozo



LHIA JUÁREZ SAMAMÉ



MAYRA LUCERO AYALA RIVERA



Natalia Villacorta Loayza



Samantha Hernández



Ximena abanto





MILAGROS Rojas Llerena

LHIA JUÁREZ S...

LHIA JUÁREZ SAMAMÉ

Samantha Hern...

Samantha Hernández

Cristina Fernánd...

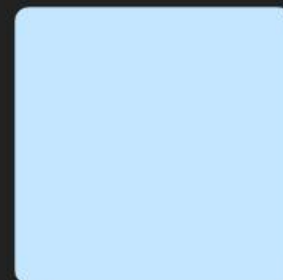
Cristina Fernández García



MAYRA LUCERO AYALA RIVERA

Daniela Yupanqui

Daniela Yupanqui



Claudia De la Cruz



Karelli Cáceres

Alessandra Padil...

Alessandra Padilla Chunga



Andrea Velasque



Ahnyela Paucar

Arantza Gamarra

Arantza Gamarra

Ximena abanto

Ximena abanto

Natalia Villacort...

Natalia Villacorta Loayza

Kimberli Cardozo

Kimberli Cardozo



COMENTARIOS